<2019 본3 학년말고사 – 정형외과->

30문제중 23문제 탐. 18야마 뿐만 아니라 16,17야마도 탔음. 2019 본1시험 1문제 탔음. **총 30문제 중 30문제 복원**

1. (야마)당뇨발 환자의 ulcer와 관련된 일차적 문제점은?
   A. 감각신경병증
   B. 혈관폐색증
   C. 감염
   D. 골절
   E. 답 아닌거
2. (야마)요통 감별과 관련되어 올바르게 질문한 것은?
   A. 신성(nephrogenic)-6주이상 지속됐나요?
   B. Radiculopathy-아침에 아프고 활동하거나 움직이면 나아지나요?
   C. 감염,종양-움직임과 상관없이 아픈가요?
   D. 마미증후군-최근 체중감소가 있었나요?
   E. PID-빈뇨 혈뇨가 있나요?
3. (야마) pneumo tourniquet에 대한 설명으로 옳은 것은?
   A. 혈관 및 조직 손상이 있을 수 있으므로 3시간 사용 후 20분 풀어준다
   B. 주요 조직손상 방지하기 위한 수술 시야 확보를 위해 사용한다.
   C. 주요 조직 손상이 일어나므로 고관절 골절의 제한된 상황에서 선택적으로 사용한다.
   D. 하지에 사용할 경우 200mmHg내외로 사용한다.
   E. 허혈이 있을 수 있기 때문에 1시간 이상 사용하면 안된다.
4. (야마)Sirt 사진 주고 다음 검사 양성인 사람 양성일 확률 낮은 검사?
   A. Bowstring
   B. Spurling
   C. Bragard
   D. Kernig
   E. Lhermitte test
5. (야마 족관절 염좌시 재활운동으로 근력을 가장 강화하여야 하는 근육은 ?
   A. Flexor hallucis longus (장무지굴근)
   B. Soleus (가자미근)
   C. Posterior tibia (후경골근)
   D. Gastrocnemius (비복근)
   E. Peroneal (비골근)
6. (야마)Thomas test에서 어떤 구축을 보이는가?
   A. 굴곡
   B. 신전
   C. 내회전
   D. 외전
   E. 내전
7. 교통사고 40/M 5cm 개방창상 맥박은 촉지되는 상태 치료는?



실제 사진은 Articular space까지 골절된 사진이었습니다.. 답 정확히 모르는데 이 2개로 얘기했습니다.

   A. 외고정술
   B. 최소침습적 금속판 고정술
   C. 골수강내 고정술

D. 관혈적 금속판 고정술

E. 석고부목

8. (야마)Patrick test 자세로 알맞은 것은

A. 굴곡 외전 외회전

B. 굴곡 내전 내회전

C. 신전 내전 내회전

D. 신전 외전 외회전

9. (야마)대퇴골두에 대해서 옳은 것은?

A. 말단 동맥으로 원형 인대 동맥, 외측 대퇴 회선 동맥, 내측 대퇴 회선 동맥 3개의 동맥이 있다.

B. 주로 공급을 담당하는 동맥은 외측 대퇴 회선 동맥이다.

C. 소아기 혈액 공급은 골 체부에서 올라온 동맥이 중요하다

D. 원형 인대 동맥은 외측 대퇴 회선 동맥에서 분지되는 것으로 대퇴골두의 혈류 공급을 책임진다.

E. 여러 동맥에서 혈류를 공급받음으로 골괴사가 잘 일어나지 않는다.

10. (야마)AVN에 대하여 옳은 것은?

A. 여성에 많다

B. 외측에 있을수록 예후가 좋다

C. T2에서 괴사된 쪽이 어둡게, 정상인 쪽이 밝게 띠를 보인다.

D. 혈액공급이 없기 때문에 수술을 필요하지 않는다.

E. 경골 골절로 유발될 경우 정확한 정복이 필요하다

11. 다음중 신경과 근육을 연결한 것으로 옳지 않은 것은? (6년째 야마 타는 듯)

A. C5-elbow flexor

B. C7-elbow extensor

C. L2-Knee extensor

D. L4-dorsiflexion

E. S1-plantarflexion

12. (야마)혈관인성 보다 신경성 파행에 더 적합한 것으로 틀린 것은?

A. 자전거 타면 통증 심해짐

B. 대퇴부 근위부 부터 아프기도 하다

C. 몸을 굽히거나 쉬면 빠르게 호전된다.

D. 내리막을 내려갈 때 증상이 더 심하다

13. (야마)53세 여성, 내원 6달전부터 발생한 주관절 통증을 주소로 내원. 주관절을 후방굴곡했을 때 주관절 외측 통증과 전완부 외측에 통증 있다고 함. 주관절 외측 부분에 압통이 있었으며, 전완을 회외전시키거나 손목관절을 신전시켰을 때 해당 부분에 통증을 호소하였다. 의심되는 질환은? (무슨 검사를 했다가 아니라 검사 방법과 모습을 묘사했습니다.)

A. 외상과염

B. 내상과염

C. 요골관증후군

D. 주관절 퇴행성 골관절염

E. 윤상인대 협착

14. (야마)경부 척수증과 디스크 탈출증 중 디스크 탈출을 더 시사하는 것

A. Shoulder abduction 시 통증 감소

B. 호프만

C. Grip release test

D. Finger escape sign

E. inverted raidal reflex

15. (야마) 다음 골절 치유과정을 보이는 골절과 치유방법은?



A. 대퇴골 간부 횡 골절- 확공성 골수내정

B. 경골 간부 횡 골절 – 압박 금속 고정판

C. 경골 간부 나선 골절 – 비확공성 골수내정

D. 대퇴골 근위 1/3 간부 분쇄 골절 – 외고정

E. 대퇴골 원위부 간부 분쇄 골절- 최소 침습적 금속판 고정술

16. (17야마) 컴퓨터는 50대 남성이 팔꿈치에 일주일전에 발생한 3X4 cm 낭종으로 내원하였다. 낭종에는 발적, 열감 소견은 보이지 않았다. 처치는?

A. 일단 사용을 줄이고 관찰해보자고 한다.

B. Steroid injection

C. Aspiration 하고 analysis

D. 항생제

E. 수술적치료

17. (17야마) 30대 여성이 요골 경상돌기 주위의 통증으로 내원하였다. 2개월전 출산하였고 최근 수유중이라고 하였고, 다음 그림과 같이 엄지를 잡고 당기면서 손 전체를 척측으로 구부리게 할 때 손목의 요측에 통증이 갑자기 증가하였다. 설명으로 옳은 것은?



A. 국소 건초 내 스테로이드 주사를 자주 실시하는 것이 좋다.

B. 이 검사법의 이름은 팔렌 검사(Phalen's test)이다.

C. 손목 배측에 6개의 신전건 구획 중 첫 번째 신전건 구획의 이상이다.

D. 보존적 치료는 효과가 없으므로 수술이 필요한 질환이다. 4~6wk splint ice->surgery

E. ?

18. (17야마)Suture와 관련하여 올바른 설명은?

A. 감염이 있으면 염증의 위험이 있으므로 빠르게 봉합한다.

B. tension이 많이 걸린 상처도 감염예방을 위해서 봉합을 해야한다.

C. 피부 봉합시 (상품명)과 같은 녹는 실을 써서 봉합한다.

D. 피부 봉합시 전체 layer를 뜨는 것 보다 superficial 만 떠야 봉합이 잘 된다.

E. Simple suture는 피부에 대해 직각으로 들어가서 직각으로 나오는 것이 원칙이다.

19. (17야마)부목에 대한 것으로 옳은 것은?

A. 발은 plantar flexion시켜서 고정해야 한다.

B. 부목 고정시 만드는 과정에서 뜨거울 수 있으니 화상을 주의해야 한다.

C. 굳을 때 최대한 손가락 끝으로 눌러서 모양을 잡아야 한다.

D. 단상지의 경우, 손목을 flexion시켜서 고정해야 한다.

E. 최대한 붕대로 압박한 뒤에 부목으로 고정시켜야 한다.

20. (16야마)요통 원인 아닌 것?

A. Ureter stone

B. 척추관 협착증

C. Internal disc disease

D. Abdominal aorta dissection

E. Osgood schlatter disease

21. (16야마)소아 골절의 remodeling과 관련된 것은?

A. 골절부위

B. 골절의 분쇄 형태

C. 골막 침범 여부

D. 성장판의 성장 여력

E. 골절형태

22. (짤야마는 아니고 매년 선지가 조금씩 바뀌어서 나오는 문제) 소아 골절의 특징이 아닌 것은?

A. 주로 보존적 치료를 한다

B. 회전변형이 일어나도 저절로 잘 치료된다.

C. 성장판으로인한 과성장이 발생할 수 있다..

D. 정확한 정복이 필요하지 않다

E. 성장판에 의한 치료

23. 30세 남자가 오토바이 사고 후 응급실에 왔다. 의식은 명료했으나 BP80/40, HR110, RR20, Hb 6.7이었다. 동반된 손상은 없었다. 다음은 골반 x-ray이다. (골반 누가 봐도 이상함) 먼저 시행해야 할 치료는?

A. 관혈적 정복 및 내고정술

B. 부목고정

C. 골견인술 및 침상안정

D. 혈관색전술

E. 외고정술

24. 28세 남자가 교통사고 후 응급실에 왔다. 우측하지에 부목고정을 한 상태였다. 우측 하퇴부 및 족부에 심한 부종, 통증 및 이상감각을 호소하였다. 동반된 손상은 없었다. 하퇴부 X ray사진이다. (tibia, fibula fracture 보이고 주변으로 soft tissue swelling 엄청 빵빵하게 보이는 사진) 진단은?

A. 외상성 반사성 교감신경 이영양증

B. 석고증후군

C. 압궤증후군

D. 구획증후군

E. 지방색전증

25. 견갑골골절, (관절와 골절-Glenoid fracture)을 관절경하 나사못 고정술을 시행하였다. 수술 후 환자는 주관절이 굴곡되지 않았고 근력은 poor degree였다. 수술 중 손상받은 신경은?

A. 상견갑신경

B. 요골신경

C. 척골신경

D. 근피신경

E. 액와신경

26. 60/F 어깨통증으로 내원. 압통은 없었으나 잠을 잘 때 아파서 잠을 제대로 못 자기도 함. 집안일을 할 수는 있었으나 무거운 물건을 들거나 높이 있는 물건을 꺼낼 때 어깨 통증이 발생함. 다음과 같은 증상을 보이는 경우에서 수동적, 능동적 운동 범위가 모두 감소할 때 가능한 진단은? (19본과야마라고함)

A. 석회성 건염

B. 회전근개 광범위 파열

C. 유착성피막염

D. 경추 신경병증

E. 다방향 불안정성

27. Meniscus로 보이는 관절경 사진. 다음 사진에서 probe로 가리키는 구조물의 기능이 아닌 것은?

A. Joint filling해서 joint conformity 증가

B. Stabilize the joint

C. Joint lubrication

D. Protect nearby tendon and to increase its mechanical effect.

E. Shock absorption

28. ACL로 보이는 관절경 사진. Probe가 당기고 있는 구조 손상의 MRI상 Direct 소견인 것은?

A. Anterior tibial translocation

B. Reduced Posterior cruciate ligament angle

C. Change in expected course of the anterior cruciate ligament

D. Characteristic bone contusion pattern

E. Uncovered posterior horn of lateral meniscus

29. 수근관 증후군 관련 설명. 52세 여자 6주간 지속된 손 저린 증상. 치료는? (근전도검사, 신경전도 검사지 있고, 검사결과에 Median nerve이상 소견)

A. 요골신경감압술

B. 척골신경감압술

C. 스테로이드 관절강 내 주사

D. 정중신경감압술

E. NSAID

30. 62/f 기르던 개에 물려 손의 dorsum쪽에 1~2cm 열상, 부종, 열감이 있었다. 응급실에서 가장 먼저 해야 할 치료는?

A. 집에서 기르던 개에 물렸으므로 별다른 조치 없이 경과관찰

B. 상처 irrigation

C. 상처 부위 배양 (Wound swab) 후 irrigation

D. Wound swab한 후 irrigation하고 항생제

E. Wound swab하고 irrigation하고 상처부위 봉합하고 항생제